



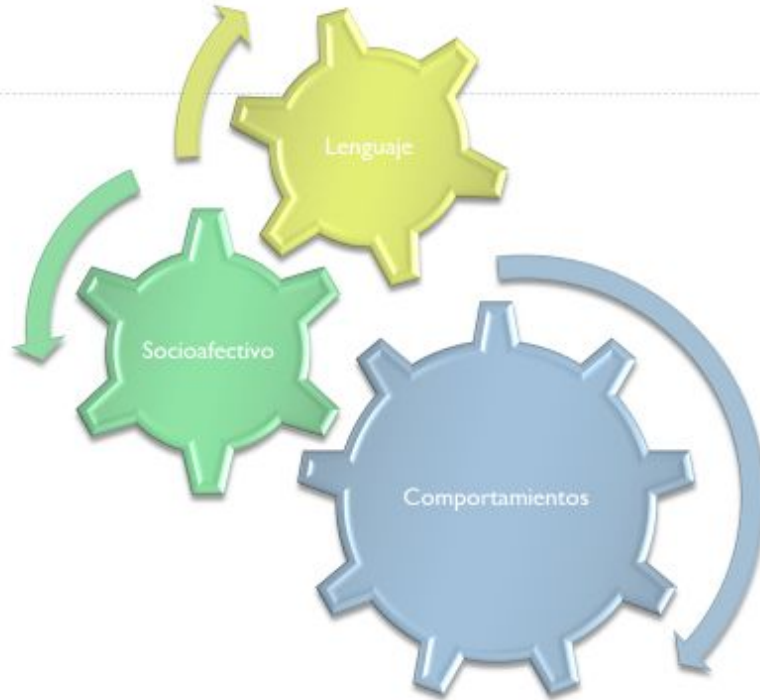
Trastorno del espectro **Autista**

Criterios Diagnósticos y Caso Clínico

Laura Camila Herrera Gómez



DSM IV- Tríada de síntomas



Tríada de Wing y Gould (1979)



Dominios del TEA DSM-5



Dificultades de Comunicación e Interacción Social

- Deficiencias en la **reciprocidad emocional**.
- Deficiencias en **conductas comunicativas NO verbales**.
- Deficiencias en el **desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones**.

Todos los criterios VARÍAN en su presentación

Comportamiento restringido y repetitivo (2 o +)

- Movimientos, uso de objetos o habla **estereotipada**.
- Insistencia en la **monotonía, inflexibilidad excesiva** de rutinas o patrones ritualizados de conducta.
- **Intereses muy restringidos** y fijos, inusuales en intensidad o foco de interés.
- **HIPER o HIPO reactividad sensorial** o interés inhabitual por estímulos del entorno



Comunicación e Interacción Social

Reciprocidad

No inician ni responden a interacciones

Imitación reducida o ausente del comportamiento de otros.

No comparten emociones, afectos o intereses

Comunicación NO Verbal

Disminución o ausencia de contacto visual

Disminución o ausencia de expresión facial

Baja comprensión y uso de gestos

Entonación de voz ausente o atípica.

Dificultades en

Comunicación e Interacción Social

Desarrollo, Mantenimiento y Comprensión de relaciones



Interés social ausente,
reducido o atípico

Rechazo o trato
inapropiado hacia otros

Falta de juegos
sociales e imaginativos
compartidos

**Dificultades
en**

Preferencia por
actividades solitarias

Ideas confusas de lo que
supone la amistad
(amistades unilaterales o
por intereses específicos)



Comportamiento restrictivo y repetitivo

Conductas Estereotipadas

Uso repetitivo de objetos

- Alinear juguetes.
- Girar monedas.

1

Estereotipias Motoras Simples

- Aleteo de Manos
- Movimiento rápido de los dedos.
- Balanceo

2

3

Habla repetitiva

- Ecolalia
- Repetición retrasada o inmediata de palabras escuchadas
- Uso del tú para referirse a sí mismo.
- Prosodia estereotipada.

Comportamiento restrictivo y repetitivo

Inflexibilidad conductual

Resistencia a los cambios

- Angustia por cambios aparentemente pequeños.
- Insistencia en seguir las reglas.
- Rigidez de pensamiento

1

2

Ritualización verbal y no verbal

- Preguntas repetitivas.
- Caminar continuamente por un perímetro

Comportamiento restrictivo y repetitivo

Intereses restringidos y reactividad sensorial

Restricciones Alimentarias

-Reacciones extremas y rituales relacionados con sabor, olor, textura o apariencia de los alimentos.

Hiporreactividad

-Aparente indiferencia al dolor, el calor o el frío.

Intereses anormales en intensidad y foco

-Fuerte apego por objetos o temas
-Pasar horas escribiendo horarios

Hiperreactividad

-Respuestas extremas a sonidos o texturas.
-Fascinación por luces u objetos que giran
-Oler o tocar objetos excesivamente.

¿Qué pasa con el lenguaje?

- Distinguir entre verbal y no verbal (En Tx de lenguaje expresivo o demoras en la adquisición se conserva el no verbal, en TEA está alterado).
- En caso de estar conservado, el lenguaje puede conservar sus capacidades formales (sintáctico, semántico, gramatical, morfológico, fonológico) **excepto en la PRAGMÁTICA** (Comunicación Social Recíproca)
 - Lenguaje **unilateral** y **literalidad**.



Según el Ciclo Vital... Primera Infancia

- Ausencia o disminución del **contacto visual**.
- No responde a la sonrisa ni a expresiones faciales de los padres.
- No responde cuando los llaman por su **nombre**.
- Movimientos estereotipados:
 - Se balancea
 - Da vueltas
 - Tuerce los dedos
 - Aletea las manos.
 - Camina en las puntas de los dedos de los pies
- Parece no sentir dolor.
- Hiper o hiposensibilidad.



Según el Ciclo Vital... **Primera Infancia**



- Alteración de la atención compartida:
 - Incapacidad de señalar con las manos o para mostrar o llevar objetos. -> **Intención Comunicativa**
 - Incapacidad para seguir cómo otro señala con las manos o dirige la mirada
- Pueden aprender algunos gestos funcionales, pero su repertorio es más pequeño. -> **Reducción de Imitación.**



Según el Ciclo Vital... Primera Infancia

- Falta de interés por la interacción social (1º año) o interacciones inusuales (llevar a alguien de la mano sin mirarlo)
- Patrones de juego extraños (llevar juguetes de un lugar a otro sin jugar)
- Paralización o regresión del desarrollo social y/o uso del lenguaje (2 años).
 - Sabe alfabeto pero no responde cuando le preguntan
 - >**Puede sospecharse sordera.**





Según el Ciclo Vital... **Niñez**

- Ausencia de juegos sociales y de imaginación compartidos o juego con reglas inflexibles.
- Las preferencias fuertes y la repetición son comunes en esa etapa. La diferencia radica en el **tipo, frecuencia e intensidad** del comportamiento
 - Un niño que alinea objetos durante horas cada día y presenta mucho malestar si se interfiere.





Según el Ciclo Vital... **Niñez**



- Dificultades para comprender el **tono** de voz, las **expresiones faciales** o el **lenguaje corporal**.
- Pueden hacerse **más dispuestos a participar pasivamente en la interacción social**, aunque la interacción es atípica.
 - Escaso sentido de los límites de los demás
- El lenguaje carece de reciprocidad y se usa para pedir o clasificar más que para conversar.

Según el Ciclo Vital... Adolescentes

- Dificultades para entender las expresiones con **sentido figurado, el humor o el sarcasmo**.
También las mentiras y la ironía.
- Dificultades al **entablar amistad** con sus compañeros.
- Excelente rendimiento en tareas de memoria a largo plazo (sin alteración cognitiva)
 - Recuerdan detalladamente horarios, fechas históricas, letras de canciones, fórmulas químicas o temas de interés.
- La información que mencionan tiende a repetirse múltiples veces y no es acorde al contexto social.



Según el Ciclo Vital... Adultos

- Los síntomas pueden coincidir con los de otro Tx Mental, como ansiedad o TDAH.
- Debe conocerse el **historial de desarrollo** temprano de la persona para obtener un diagnóstico preciso.
- Aprenden a suprimir conductas repetitivas en público.
- Solo un pequeño porcentaje llega a vivir y trabajar de forma autónoma en la adultez. ->**Intereses restrictivos.**



Según el Ciclo Vital... Adultos



- Las deficiencias en la **reciprocidad socioemocional** al responder a señales sociales complejas
 - Comprender cuándo y cómo unirse a una conversación
 - Distinguir cosas que no deben decirse.
- Si han generado **estrategias de compensación**, siguen teniendo problemas en situaciones nuevas o sin ayuda.
- Ansiedad por tener que calcular conscientemente lo que es intuitivo para los demás.

Prevalencia

Cerca del 1% de la población tiene TEA

- **Es 4 veces más frecuente en Niños que en Niñas.**
Tanto en TEA típico como en TEA de alto funcionamiento.
- **Las niñas tienen más posibilidad de presentar discapacidad intelectual acompañante.**



Diferencias en los Criterios

DSM-IV

- 3 dominios de base: Reciprocidad social, Lenguaje y comunicación e Intereses y actividades restringidos.
- Se incluye el retraso en el lenguaje como criterio para el Dx.
- Deben aparecer antes de los **36 meses**.
- Clasificado como Tx Generalizado del Desarrollo.

DSM-5

- 2 dominios de base: Comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos.
- Se adopta la característica de **espectro**.
- Se excluye retraso en el lenguaje como criterio para el Dx.
- Se incluye la **reactividad** inusual a estímulos **sensoriales**.
- Deben estar presentes desde la **infancia temprana**, considerando exigencias sociales.
- Clasificado como Tx del Neurodesarrollo.
- Incluye categorías de Tx de Asperger, Tx Generalizado del desarrollo no especificado



Diferencias en los Criterios

CIE-10

- Permanece clasificado como un Tx Generalizado del Desarrollo.
- Es independiente del Asperger y el Síndrome de Rett.
- Dificultades en el lenguaje como criterio diagnóstico.
- Autismo atípico por la edad de inicio (>36 meses).

CIE-11

- Clasificado como Tx del Neurodesarrollo.
- Desaparece el Síndrome de Asperger y de Rett.
- No requiere un número determinado de criterios.
- Autismo atípico por síntomas clínicos.

→ Se pone en duda la existencia del Síndrome de Asperger, por similitud biológica y genética con Autismo.

→ Se retira Síndrome de Rett dado que tiene fisiopatología diferente, a pesar de que comparta algunos síntomas.

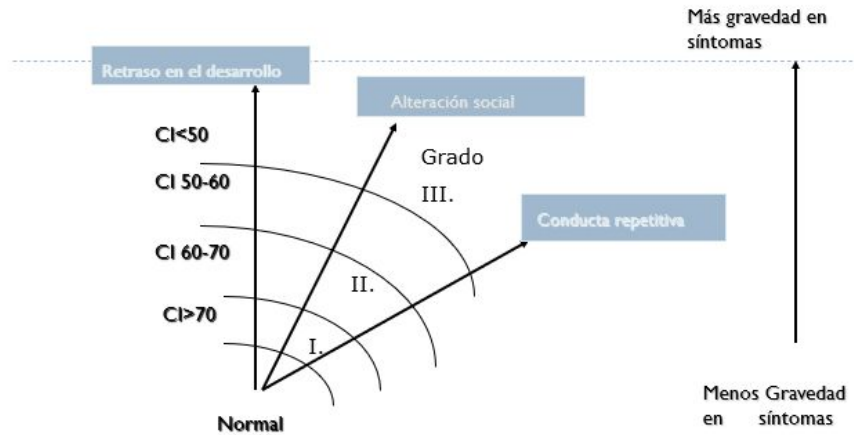
Críticas al DSM y CIE

- La crítica principal es la estrechez de los nuevos criterios del DSM-5, pues se corre el riesgo de excluir a personas del diagnóstico:
 - >10 al 40% de personas que cumplían criterios en el DSM-IV no lo hacen en el DSM-5.
- Introducción del Tx. de la comunicación social, pues se desconoce su relación con el TEA.
- Introducción de Asperger dentro de TEA y eliminación en CIE socava la identidad de las personas afectadas por el síndrome.
- Nuevamente son criterios categoriales, que pueden solaparse con otros diagnósticos.

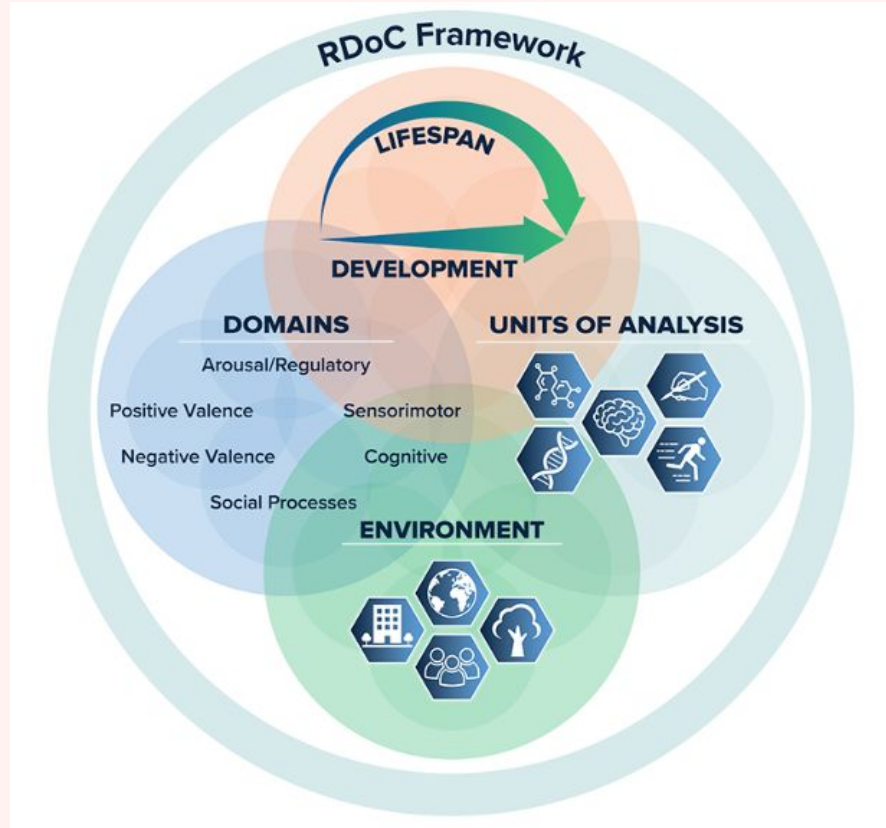
Clasificación

TABLA 2 Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo

Nivel de gravedad	Comunicación social	Comportamientos restringido y repetitivos
Grado 3 "Necesita ayuda muy notable"	Las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras inteligibles que raramente inicia interacción y que, cuando lo hace, realiza estrategias inhabituales sólo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas.	La inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos/ repetitivos interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa/dificultad para cambiar el foco de acción.
Grado 2 "Necesita ayuda notable"	Deficiencias notables de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal; problemas sociales aparentes incluso con ayuda <i>in situ</i> ; inicio limitado de interacciones sociales; y reducción de respuesta o respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona que emite frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica.	La inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos/ repetitivos aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad y/o dificultad para cambiar el foco de acción.
Grado 1 "Necesita ayuda"	Sin ayuda <i>in situ</i> , las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes. Dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito.	La inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos. Dificultad para alternar actividades. Los problemas de organización y de planificación dificultan la autonomía.



Recordando los RDoC...



Criterios RDoC... Dominio **Valencia Positiva**

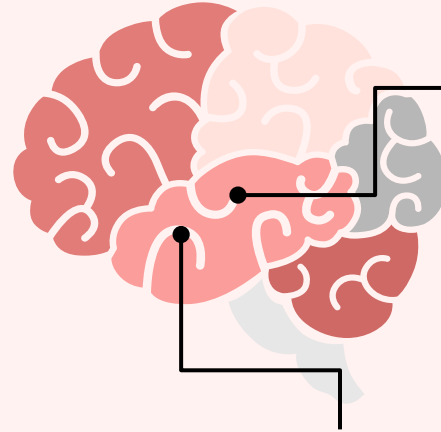
Sistema de Recompensas



Baja expectativa de ganancia monetaria

Baja anticipación de recompensas sociales y dificultades en procesamiento de interacciones sociales valiosas.

-> Similar en ansiedad social



Baja activación del **estriado ventral** en anticipación de recompensa.

Núcleo accumbens con funcionamiento reducido.



Criterios RDoC... Dominio **Procesos Sociales**

Percepción facial y ToM



Deficiencias en la percepción de las expresiones faciales emocionales.

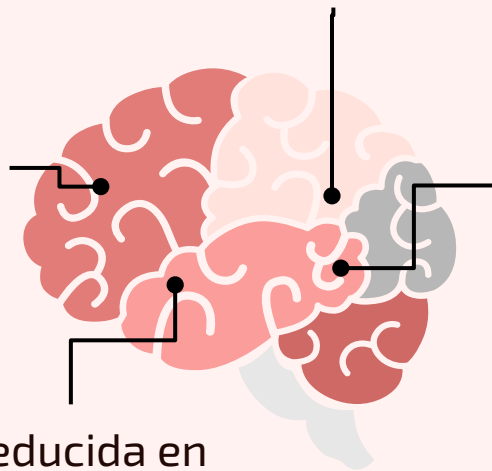
Dificultades en desarrollo de ToM, empatía y comprensión de estados emocionales.

ToM de primer orden no está afectada en el laboratorio.

Actividad reducida en **unión temporoparietal (TPJ)**

Hipoactivación **prefrontal medial**

Hipoactivación en **área facial fusiforme**



Actividad reducida en **amígdala** (aumenta cuando se pide mirar a los ojos)





Criterios RDoC... Dominio **Cognitivo**

Funciones Ejecutivas



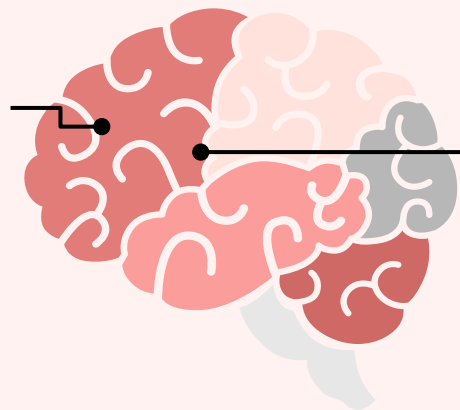
Afectación más generalizada en TEA que en TDAH.

Dificultades en planeación, monitorización, flexibilidad e inhibición.

WCST es muy usado en la investigación.

Alteración funcional en corteza **prefrontal dorsolateral**

Alteración en **corteza cingulada anterior dorsal** y **corteza cingulada posterior**.



C.A.R.S. (Childhood autism rating scale)

Puntuación >30

I	Relación con la gente	VIII	Respuesta Auditiva
II	Imitación	IX	Uso y rta del gusto, olfato y tacto
III	Respuesta emocional	X	Miedo o Nerviosismo
IV	Uso del cuerpo	XI	Comunicación Verbal
V	Uso del objeto	XII	Comunicación no verbal
VI	Adaptación al cambio	XIII	Nivel de actividad
VII	Respuesta Visual	XIV	Nivel y consistencia de la rta emocional

Caso Clínico VO.



Información Sociodemográfica

Edad	2 años y 2 meses
Sexo	Femenino
Lateralidad	Ambidextra

Escolaridad	No escolarizada
Remite	Genética
Acompañante	Madre

Motivo de Consulta:

- ❖ Remitida por genética por sospecha de autismo.
- ❖ Múltiples antecedentes: Alteración en gen PTEN y **Síndrome de Cowden**.
- ❖ “No habla nada, no hacía contacto visual con nadie, aunque ahora ya lo hace... ha logrado decir palabras muy cortas”.



Síndrome de Cowden

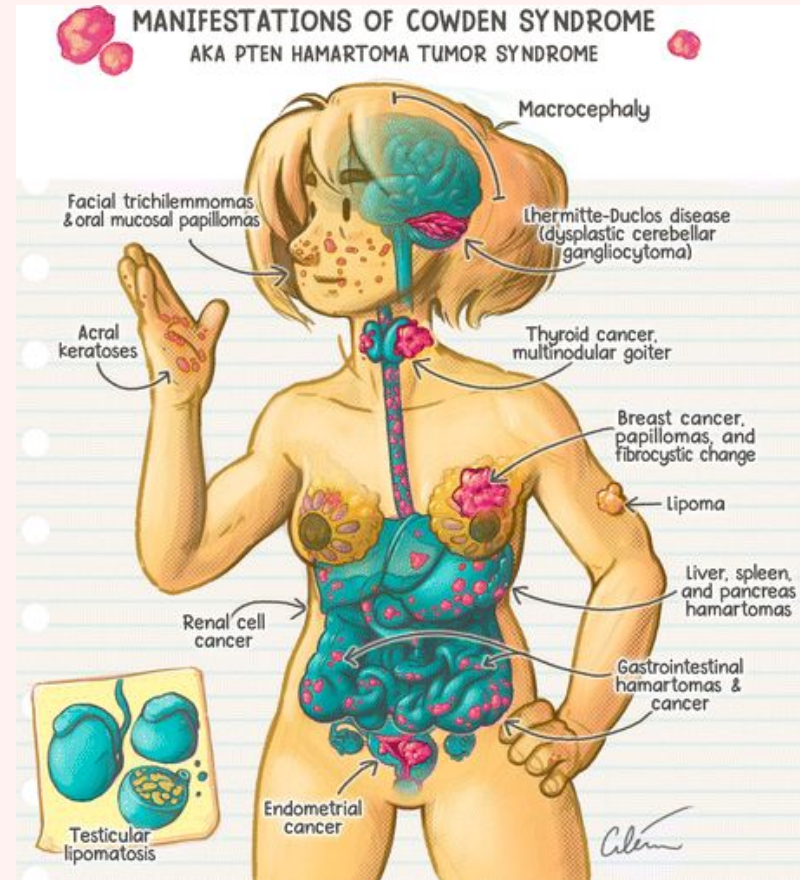
Enfermedad hereditaria, caracterizada por formación de tumores benignos (hamartomas) y alto riesgo de cáncer (de mama, de tiroides y de endometrio)..

Los síntomas incluyen **macrocefalia**, tumores del folículo piloso y ampollas blancas en la boca.

Asociado con: **Tumores cerebrales, Tx del espectro autista y discapacidad intelectual.**

->Enfermedad autosómica dominante, aunque puede ser variante de novo

->Alteración en **Gen PTEN** (asociado a TEA)



Gen PTEN y Autismo

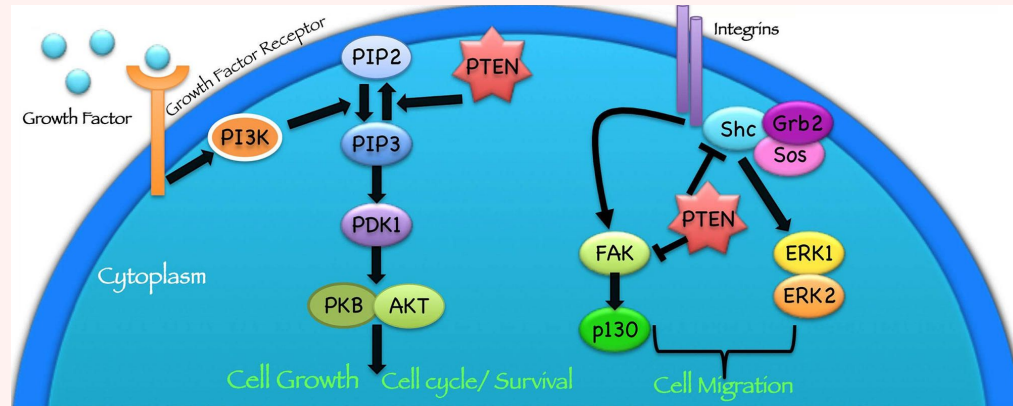
Gen PTEN tirosina fosfatasa se encuentra en el cromosoma 10q23.

->Es un *supresor tumoral*, protector contra la oncogénesis.

Hasta el 30% de los casos de TEA pueden tener una etiología genética detectable.

TEA con Macrocefalia: El tamaño anormal de la cabeza es una condición comúnmente coexistente en el TEA.

->10 al 20% de los pacientes con TEA presentan macrocefalia y anomalías marcadas en sustancia blanca, cuyo 10% presenta deterioro intelectual



Gen PTEN y Autismo

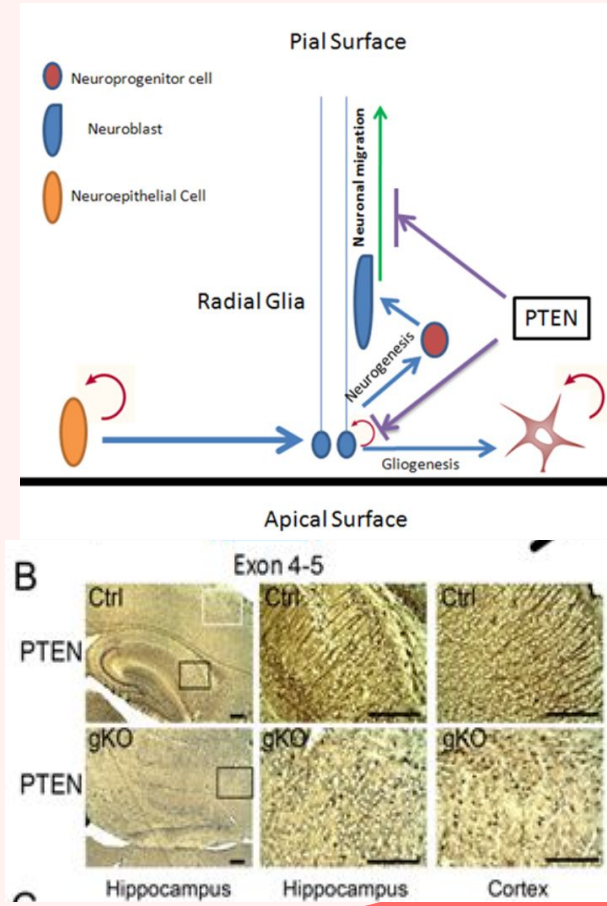
->El gen PTEN regula la **proliferación de las células gliales radiales** en las primeras etapas del neurodesarrollo.

->PTEN se encuentra elevado en células astrogliales en personas con TEA, sugiriendo que existe una **proliferación excesiva de células gliales** en TEA como factor desencadenante.

->PTEN es importante durante la neurogénesis y el mantenimiento neuronal

->Pacientes con mutaciones PTEN y TEA tienen altas probabilidades de tener problemas de **motricidad** (fina y gruesa), **disminución en la velocidad de procesamiento** y **deficiencias a nivel de la Memoria de Trabajo**, acompañado de desregulación del comportamiento y disfunción sensorial.

->Parecen tener un patrón específico de materia blanca aumentada y poco desarrollada -> Déficits en MT y VP





Antecedentes del Desarrollo



Edad Materna	34	Estrés Prenatal	Todo el embarazo, por dificultades con el esposo y la pandemia.		
#Gestación	3	Condiciones Neonatales	Normales	Tipo de Parto	Vaginal
Talla	49 cm	Peso	3150 gr	Incubadora	No
Riesgos	-CPN+ -Polihidramnios (acumulación de líquido amniótico) -HTA, con anticoagulación. -Inducción con Pitocin.				

Motor

- ❖ Sostén Cefálico: 4 meses
- ❖ Sedestación: 8 meses
- ❖ Gateo: 10 meses
- ❖ Marcha: 12 meses

Lenguaje

- ❖ Balbuceo: Normal
- ❖ Primeras Palabras: Bisílabos
- ❖ Habla Claro: NO.





Funciones Cognitivas y Comportamiento



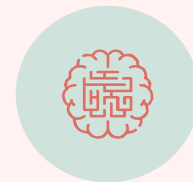
Interacción Social

Sonrisa Social al mes.
Contacto visual en lactancia
Cuando la llaman no mira



Lenguaje

-Responde al nombre
-No hay Holofrases
-Se comunica por señalamiento y uso instrumental del adulto.
-Hay Onomatopeyas ("ladra")



Praxias

Coge el lápiz e intenta rayar
Le gustan los juegos del parque



Memoria

Se acuerda de lo que le enseñan

- ❖ Balanceo a los 15 meses (lo dejó).
- ❖ Juega con su sombra y mueve en círculos sus manos.
- ❖ Irritable cuando la ponen a hacer algo que no quiere.
- ❖ Le gusta tener algo en la mano.
- ❖ La música fuerte la incomoda.
- ❖ Se tapa los oídos con el pito del carro.
- ❖ Es cariñosa con los padres cuando quiere
- ❖ No mide riesgos, en general no es temerosa.





Antecedentes Comportamentales

Vive con	Padres y hermanos de 15 y 9 años. Juega con sus hermanos, los abraza y los llama a comer.
Funcionalidad	No se ha dejado quitar el pañal. Está aprendiendo a subir escaleras. Come sola con la mano y sostiene su vaso.
Sueño y Alimentación	->Se pasa a la cama de los papás y se despierta varias veces. Duerme una hora y se despierta llorando. Ronca. ->Alinea alimentos redondos y se los come en orden. Antes comía carne, ahora la mastica y la escupe lejos. Por épocas tiene comidas especiales. Mezcla texturas.
Escolar	No escolarizada. Cuando ve niños de su edad se alegra, pero luego se aburre y se va.



Antecedentes Médicos

→Patológicos:

- Puente nasal amplio.
- Alteración en gen PTEN y Sx de Cowden.
- Bronquiolitis sincitial y adenovirus al año y 2 meses, con hospitalización y oxígeno.
- Incremento del perímetro cefálico a los 15 días de nacida.
- Respiradora Bucal.
- SARS-CoV-2 al año.



Antecedentes **Médicos**

- **Farmacológicos:** Beclometasona (a necesidad).
- **Motores:** Camina de rodillas.
- **Terapéuticos:** Lenguaje. Pendiente Ocupacional.
- **Familiares:** Abuela paterna CA linfático. HTA en ambos abuelos. Hermano medio con dificultades de articulación y mezcla de letras. El abuelo materno se demoró en hablar.



→ **Paraclínicos:**

- ❖ **Potenciales evocados:** Integridad de vías auditivas
- ❖ **EEG Normal**
- ❖ **Exoma trío:** PTEN (MIM*601728), c.371G>A (p.Cys124Tyr), NM 000314.8, Het, Síndrome de Cowden 1 (MIM#158350), Síndrome de macrocefalia/autismo (MIM#605309).
- ❖ **iRM cerebro simple:** Aparente alteración de la sustancia blanca periatrinal bilateral, a correlacionar con antecedentes perinatales de la paciente. Quiste aracnoideo temporal medio izquierdo. Imagen de quiste de fisura coroidea izquierda.





Observación Conductual

- Se muestra activa y responsiva al entorno.
- Atiende cuando se le hace llamado.
- Se interesa tanto en la evaluadora como en las actividades que se le proponen.
- Intenta repetir los sonidos que se le expresan, pero con limitaciones en volumen y producción.
- Hace buen contacto visual y muestra comodidad en la interacción.
- Permite el contacto físico (busca contacto con evaluadora).



Resultados Escalas

Vineland

Esperado
36

Edad Social: 1,65



CARS

Esperado
<30

Negativo



→ No se evidencian indicadores conductuales relevantes asociados con TEA... CARS Negativo



Resultados Escala Abreviada de Desarrollo

Motricidad Gruesa

En Riesgo



Motricidad Fina

Nivel Medio



Audición/Lenguaje

En Riesgo



Personal Social

En Riesgo (por comunicación)



TOTAL EAD-> En RIESGO

Indicadores de posible DESINTEGRACIÓN SENSORIAL



Conclusiones **Atención**

La paciente presenta dificultades en:

- ❖ Depende de atención externa guiada por objetos (se orienta a lo llamativo).
- ❖ Pierde rápido la información y requiere repetición.
- ❖ Volumen atencional máx 2 pasos

La paciente conserva:

- ❖ Activa y vigilante de forma estable
- ❖ Respuesta dinámica a estímulos.
- ❖ Recuerda y retoma actividades.
- ❖ Mayor atención a elementos visuales que verbales.



Conclusiones **Memoria**

La paciente presenta dificultades en:

- ❖ Dificultad en expresión de gestos imitados

La paciente conserva:

- ❖ Recuerda actividades propuestas y uso de objetos y herramientas.
- ❖ Muestra capacidad de imitación a través de la acción.
- ❖ Intenta hacer imitación de gestos y sonidos.
- ❖ Recuerda la ubicación de objetos y los reconoce ante la repetición.



Conclusiones Praxias y Gnosias

La paciente presenta dificultades en:

- ❖ Dificultades al atrapar, lanzar y patear, aunque lo hace con apoyo.
- ❖ Menor equilibrio dinámico.
- ❖ Inmadurez en coordinación motriz.
- ❖ Hipersensibilidad y defensibilidad táctil y a texturas alimenticias.
- ❖ No le gusta el contacto físico directo, pero acepta el contacto en sus manos.
- ❖ Bajo tono muscular

La paciente conserva:

- ❖ Realiza movimientos de tronco y extremidades,
- ❖ Mejor equilibrio estático, Marcha autónoma y explora el entorno.
- ❖ Mantiene la posición en la silla el tiempo suficiente para la edad.
- ❖ Hace rayones con lápiz, tomándolo con la mano completa.
- ❖ Traza líneas rectas y circulares por imitación.
- ❖ Muestra habilidades de imitación, intentando repetir gestos y sonidos.



Conclusiones **Lenguaje**

La paciente presenta dificultades en:

- ❖ Expresión limitada de sonidos para la edad.
- ❖ No hay balbuceo evidente espontáneo.
- ❖ Dificultades articulatorias, posiblemente asociadas a bajo tono muscular de aparato bucofonatorio.

La paciente conserva:

- ❖ Demuestra **intención comunicativa**, con lenguaje no verbal, e intenta hacer expresión verbal.
- ❖ Atiende a las indicaciones y se beneficia del ejemplo.



Funciones **Ejecutivas**

La paciente presenta dificultades en:

- ❖ Muestra interés por la seriación

La paciente conserva:

- ❖ Sostiene mirada y responde, participando e invitando al adulto a jugar.
- ❖ Cambia de actividad y se ajusta al solicitarle una nueva.
- ❖ **Se adapta al cambio.**
- ❖ Hay **juego cooperativo (con adultos), simbólico y roles** apropiados para la edad.

- 
- **Bajo contacto visual. (Aunque estuvo presente durante la lactancia)**
 - Juega cargando a los bebés "le gusta arroparlos y les da un besito".
 - Invita a la mamá a jugar e imita a los hermanos.
 - Responde al nombre
 - **Se tapa los oídos con el pito del carro y música fuerte.** Aunque tolera sonido de licuadora y taladro.
 - **A veces se pega fuerte y no llora.**
 - **No le gusta jugar con arena (provoca náuseas)**
 - Bajo desarrollo del lenguaje. -> No hace holofrases, aunque se expresa con onomatopeyas.
 - Cuando ve niños de su edad se alegra, pero luego se aburre y se va.
- 



¿Desintegración Sensorial?

0 Tx de Integración sensorial

Es la dificultad del procesamiento y la organización cerebral de la información proveniente de los órganos de los sentidos, cuando todos ellos están en sano funcionamiento.

- >Hiper o hiposensibilidad sensorial
- >Torpeza y falta de coordinación
- >Distractibilidad.

Los niños hiposensibles tienen poca sensibilidad, lo que los hace buscar más estimulación sensorial, provocando que ellos:

- Tengan una necesidad constante de tocar a las personas o texturas, incluso cuando no es socialmente aceptable.
- No entiendan qué es el espacio personal, incluso cuando los niños de su misma edad ya lo comprenden.
- Tengan una tolerancia extremadamente alta al dolor.
- No sean conscientes de su fuerza.
- Sean muy inquietos y tengan dificultad para quedarse sentados.
- Adoren las actividades que implican saltar, chocar y estrellarse.
- Disfruten la presión profunda, como abrazos muy apretados.
- Prefieran los movimientos rápidos, intensos y/o giratorios.
- Quieran que los lancen al aire y saltar sobre los muebles y trampolines.



Conclusiones del Caso

- VO. Manifiesta demoras generalizadas en su desarrollo
- Muestra inmadurez en motricidad gruesa, demoras en desarrollo verbal y limitaciones en la interacción social.
- Indicadores de **desintegración sensorial**
- Se DESCARTAN elementos para el TEA, mostrando un perfil más compatible con **demora generalizada en el desarrollo.**



**Muchas
Gracias**



Referencias

Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2000). *Manual Estadístico y Diagnóstico de los trastornos mentales* (4° Edición ed.).

Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2014). *Manual estadístico y Diagnóstico de los trastornos mentales* (5° edición ed.). Médica Panamericana.

National Institute of Mental Health. (s.f.). *About RDoC*. Obtenido de National Institute of Mental Health: <https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/about-rdoc>

Navarro-Soria, I., Fenollar, J., Carbonell, J., & Real, M. (Enero de 2020). Memoria de trabajo y velocidad de procesamiento evaluado mediante WISC-IV como claves en la evaluación del TDAH. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 23-29. doi:10.21134/rpcna.2020.07.1.3

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1995). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Décima revisión (CIE-10)*. Washington D.C.

Referencias

<http://www.aginganddisease.org/EN/Y2013/V4/I3/113#14>

<https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.210230>

<https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13194/sindrome-de-cowden>

[https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/380/933#:~:text=Estudios%20recientes%20informaron%20que%20el,se%20mantiene%20incierto%20\(15\).](https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/380/933#:~:text=Estudios%20recientes%20informaron%20que%20el,se%20mantiene%20incierto%20(15).)

<https://www.kyriossuit.com/post/una-decisi%C3%B3n-sensorial-importante-en-el-autismo-y-o-trastorno-del-procesamiento-sensorial>

<https://neurocomgroup.com/desintegracion-sensorial/#:~:text=M%C3%A1s%20conocido%20como%20trastorno%20de,ellos%20est%C3%A1n%20en%20sano%20funcionamiento.>

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/Escala-abreviada-de-desarrollo-3.pdf>